التوجيه والإرشاد الطلابي · دراسات حالة

ملف البحوث التشخيصية لدراسة الحالات الطلابية

سبعة بحوث تشخيصية متكاملة وبحث إجرائي لأبرز مشكلات متعلمي المرحلة الابتدائية من البنين والبنات

غياب أحد الوالدين · ضعف القراءة والكتابة · السلوك العدواني والتنمر · الانطواء والخجل
التأخر والغياب المتكرر · تشتت الانتباه وفرط الحركة · الإفراط في الأجهزة الذكية

بحث إجرائي: الكتابة على الطاولات

الابتدائية السابعة والستون

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · تاريخ الإصدار **18/5/1448هـ**

وثيقة مهنية سرية · جميع الأسماء الواردة رمزية حفاظاً على خصوصية المتعلمين وأسرهم



بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

سورة طه – الآية 114



المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن العناية بالمتعلم بوصفه محور العملية التعليمية لا تقتصر على الجانب المعرفي وحده، بل تمتد لتشمل نموه النفسي والاجتماعي والسلوكي والصحي؛ إذ لا يمكن لمتعلم يعاني من اضطراب في أي من هذه الجوانب أن يحقق أقصى ما تسمح به قدراته. ومن هنا تبرز أهمية البحث التشخيصي (دراسة الحالة) أداةً مهنيةً تمكّن المدرسة من فهم المشكلة فهماً عميقاً قبل التدخل فيها، والانتقال من ردود الأفعال الآنية إلى المعالجة المبنية على الشواهد والبيانات.

وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جعلت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتماشياً مع توجهات وزارة التعليم في تعزيز الصحة النفسية والانضباط المدرسي ورفع جودة نواتج التعلم، حرصت الابتدائية السابعة والستون بالطائف على توثيق عدد من البحوث التشخيصية لحالات واقعية الطابع تمثّل أبرز المشكلات التي يواجهها متعلمو المرحلة الابتدائية من البنين والبنات.

ويضم هذا الملف سبعة بحوث تشخيصية متكاملة، يتناول كل منها مشكلة محددة وفق منهجية علمية موحدة تبدأ بجمع البيانات، مروراً بتحليل الأسباب وصياغة التشخيص، وانتهاءً ببناء خطة علاجية قابلة للقياس ومتابعتها وتقويم أثرها. وقد رُوعي في جميع الحالات استخدام أسماء رمزية حفاظاً على سرية المعلومات وخصوصية الأسر. كما يضم الملف بحثاً إجرائياً مدرسياً بعنوان (الكتابة على الطاولات والجدران) يعالج ظاهرة تمس البيئة المدرسية بأكملها، ويقيس أثر التدخل على مدى ثلاثة أشهر، إضافة إلى بحثين موثّقين نفّذتهما المدرسة في العام الدراسي 1447هـ (حالة غياب أحد الوالدين، وحالة صحية لطالبة مصابة بالسكري)، والبرامج الوقائية المساندة المنفّذة في العام الحالي.

نسأل الله أن يكون هذا العمل لبنةً في بناء بيئة مدرسية آمنة ومحفّزة، وأن ينفع به أبناءنا وبناتنا، وأن يكون مرجعاً عملياً لمنسوبات المدرسة في التعامل المهني مع الحالات الطلابية.

والله ولي التوفيق ،،،
مديرة المدرسة: ناديه عوض الصخيري

فهرس المحتويات

المقدمة	3
الإطار النظري للبحث التشخيصي	5
ملخص الحالات المدروسة	8
1 الحالة الأولى: غياب أحد الوالدين وأثره على التحصيل والاستقرار النفسي	9
2 الحالة الثانية: ضعف مهارات القراءة والكتابة	13
3 الحالة الثالثة: السلوك العدواني والتنمر على الزملاء	17
4 الحالة الرابعة: الانطواء والخجل الاجتماعي	21
5 الحالة الخامسة: التأخر الصباحي والغياب المتكرر	25
6 الحالة السادسة: تشتت الانتباه وفرط الحركة	29
7 الحالة السابعة: الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية	33
نماذج التواصل مع أولياء الأمور	37
بحث إجرائي: الكتابة على الطاولات والجدران	40
التطبيق المبسّط للبحث الإجرائي	45
بحوث موثّقة من العام الدراسي 1447هـ	53
البرامج الوقائية المساندة 1448هـ	58
الخاتمة والتوصيات العامة	60
المرجعية واعتماد الملف	61

الإطار النظري للبحث التشخيصي

1 مفهوم البحث التشخيصي

البحث التشخيصي (دراسة الحالة) منهج علمي منظم يهدف إلى جمع المعلومات الشاملة عن متعلم يعاني من مشكلة دراسية أو سلوكية أو نفسية أو اجتماعية، وتحليلها تحليلاً دقيقاً للوصول إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، ثم وضع خطة علاجية مناسبة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.

2 أهداف البحث التشخيصي

- تحديد المشكلة تحديداً دقيقاً وقياس حجمها ومدى تكرارها وتأثيرها.
- الكشف عن الأسباب الذاتية والأسرية والمدرسية والاجتماعية المؤدية إليها.
- بناء خطة علاجية فردية واقعية قابلة للتنفيذ والقياس.
- توحيد جهود المدرسة والأسرة والجهات المساندة حول المتعلم.
- الوقاية من تفاقم المشكلة واكتشاف الحالات المشابهة مبكراً.
- توثيق الممارسات المهنية وتكوين قاعدة معرفية تفيد في الحالات المستقبلية.

3 خطوات البحث التشخيصي

1. **الرصد والإحالة:** ملاحظة المشكلة من قبل المعلمة أو ولي الأمر أو الإدارة، وإحالة الحالة رسمياً إلى الموجهة الطلابية.
2. **جمع البيانات:** استخدام أدوات متعددة: المقابلة، الملاحظة، السجلات، الاختبارات التشخيصية، الاستبانات، وتقارير المعلمات.
3. **تحليل الأسباب:** تصنيف العوامل المؤثرة إلى ذاتية وأسرية ومدرسية واجتماعية، وتحديد السبب الرئيس والأسباب المساعدة.
4. **صياغة التشخيص:** صياغة عبارة تشخيصية موجزة ودقيقة تصف المشكلة وأسبابها المرجّحة.
5. **بناء الخطة العلاجية:** تحديد أهداف قابلة للقياس وإجراءات ومسؤوليات وجداول زمنية ومؤشرات نجاح.
6. **التنفيذ والمتابعة:** تطبيق الخطة ومتابعتها دورياً وتوثيق التقدم أسبوعاً بأسبوع.

7 **التقويم والإغلاق:** قياس أثر التدخل ومقارنته بخط الأساس، ثم إغلاق الحالة أو تعديل الخطة أو الإحالة لجهة متخصصة.

4 أدوات جمع المعلومات

الأداة	الاستخدام
المقابلة	فردية مع المتعلم، ومع ولي الأمر، ومع المعلمات ذوات العلاقة.
الملاحظة المنظمة	رصد السلوك في مواقف محددة باستخدام بطاقات ملاحظة ذات تكرارات وأوقات.
السجلات المدرسية	سجلات الحضور والغياب، والتحصيل، والسلوك، والملف الصحي.
الاختبارات التشخيصية	اختبارات المهارات الأساسية وقياس الفاقد التعليمي.
المقاييس والاستبانات	مقاييس مقننة مناسبة للمرحلة العمرية تطبّقها الجهة المختصة.
الرسم والتعبير الحر	أدوات إسقاطية مساعدة تكشف المشاعر لدى الأطفال الصغار.

5 الضوابط الأخلاقية والمهنية

- السرية التامة لمعلومات الحالة، وحفظ الملف لدى الموجهة الطلابية فقط.
- استخدام الأسماء الرمزية في أي توثيق أو عرض.
- الحصول على موافقة ولي الأمر قبل تطبيق المقاييس أو الإحالة الخارجية.
- احترام كرامة المتعلم وتجنب الوصم أو المقارنة أمام الآخرين.
- عدم إصدار أحكام طبية أو نفسية، والإحالة للجهة المختصة عند الحاجة.
- العمل بروح الفريق مع إطلاع كل طرف على ما يخصه فقط.

6 الشراكة مع ولي الأمر ودور مديرة المدرسة

التواصل مع ولي الأمر جزء من العلاج

بناءً على توجيه المشرفة التربوية، دُمج التواصل مع ولي الأمر في كل حالة بوصفه جزءاً من العلاج لا إجراءً إدارياً منفصلاً؛ فالأسرة شريك في التشخيص وفي تنفيذ الخطة وفي قياس أثرها، وتتولى مديرة المدرسة ترؤس لقاءات ولي الأمر واعتماد الاتفاقات ومتابعة الحالة دورياً حتى إغلاقها.

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.

- تذليل العقبات (تعديل الجدول، توفير وسائل، تنسيق مع المعلمات أو الجهات المساندة).
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.
- إشعار ولي الأمر رسمياً عند عدم التعاون، والرفع لإدارة التعليم وفق القنوات النظامية عند الحاجة.

ملخص الحالات المدروسة

يعرض الجدول التالي ملخصاً للحالات السبع التي تناولها الملف، وقد رُوعي في اختيارها أن تغطي المجالات النفسية والاجتماعية والتعليمية والسلوكية والانضباطية والصحية، وأن تشمل البنين في صفوف الطفولة المبكرة والبنات في مختلف صفوف المرحلة.

م	المشكلة	الحالة	الصف	المجال
1	غياب أحد الوالدين وأثره على التحصيل والاستقرار النفسي	الطالبة (ر)	الرابع الابتدائي	نفسي – اجتماعي
2	ضعف مهارات القراءة والكتابة	الطالب (م)	الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)	تعليمي – تحصيلي
3	السلوك العدواني والتنمر على الزملاء	الطالب (ع)	الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)	سلوكي
4	الانطواء والخجل الاجتماعي	الطالبة (ن)	الثاني الابتدائي	نفسي – اجتماعي
5	التأخر الصباحي والغياب المتكرر	الطالبة (ه)	السادس الابتدائي	انضباطي – أسري
6	تشتت الانتباه وفرط الحركة	الطالب (ف)	الأول الابتدائي (الطفولة المبكرة)	سلوكي – تعليمي
7	الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية	الطالبة (ج)	الخامس الابتدائي	سلوكي – صحي

المنهجية الموحدة لعرض كل حالة

- بيانات الحالة الأساسية (بأسماء رمزية).
- وصف المشكلة ومظاهرها السلوكية القابلة للملاحظة.
- أدوات التشخيص المستخدمة ونتائج كل أداة.
- تحليل الأسباب: ذاتية – أسرية – مدرسية.
- العبارة التشخيصية.
- الخطة العلاجية: الهدف، الإجراء، المسؤول، المدة، مؤشر النجاح.
- المتابعة والتقويم الأسبوعي.
- التوصيات.
- الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة (خطة تواصل، مهام ولي الأمر، إقرار).
- الاعتماد والتواقيع.

البحث التشخيصي – الحالة الأولى

1 غياب أحد الوالدين وأثره على التحصيل والاستقرار النفسي

المجال: **نفسي – اجتماعي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي **الطالبة (ر)**	الصف **الرابع الابتدائي**	العمر **9 سنوات**
ترتيبها بين إخوتها **الثانية من ثلاثة**	جهة الإحالة **معلمة الصف ورائدة الفصل**	تاريخ الإحالة **الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

لوحظ على الطالبة (ر) منذ بداية العام الدراسي تراجع ملحوظ في مستواها الدراسي بعد أن كانت من المتفوقات في الأعوام السابقة، مصحوباً بميل إلى العزلة وشرود الذهن والبكاء دون سبب ظاهر أثناء الحصص. وبالرجوع إلى ملفها وبمقابلة ولية أمرها تبيّن أن والدها توفي قبل نحو ثمانية أشهر، وأن الأسرة انتقلت للسكن مع الجدة، وأن الأم انشغلت بأعباء العمل ورعاية الأسرة منفردة.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- انخفاض المعدل التحصيلي من (ممتاز) إلى (جيد) في الرياضيات والعلوم خلال فترة وجيزة.
- شرود الذهن وضعف التركيز وعدم إكمال الواجبات الصفية والمنزلية.
- العزلة عن الزميلات وتجنّب الأنشطة الجماعية والإذاعة المدرسية التي كانت تشارك فيها.
- نوبات بكاء متكررة خاصة في حصص التعبير وعند الحديث عن الأسرة.
- شكاوى جسدية متكررة (صداع، ألم بطن) دون سبب عضوي واضح، وطلب الاتصال بالأم.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
مقابلة الطالبة	ثلاث جلسات فردية بأسلوب الحوار الداعم والرسم الحر	مشاعر حزن وخوف من فقدان الأم، وإحساس بأن البيت تغيّر
مقابلة ولية الأمر	جلستان (حضوري وهاتفي)	تأكيد ظروف الفقد والانتقال، وضيق وقت الأم وقلقها على ابنتها
تقارير المعلمات	استمارة رصد من معلمات الرياضيات والعلوم ولغتي	تراجع المشاركة والتركيز، وتذبذب أداء الواجبات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
السجلات المدرسية	مراجعة درجات العامين السابقين والحضور	انخفاض واضح بعد الفقد، وغياب متقطع (6 أيام)
الملاحظة المنظمة	بطاقة ملاحظة لمدة أسبوعين في الفصل والفسحة	انعزال في 80% من فترات الفسحة
الملف الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	لا توجد أمراض عضوية مسجلة

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- مشاعر الحزن والفقد غير المعبَّر عنها بصورة صحية.
- قلق الانفصال والخوف من فقدان الأم.
- انخفاض تقدير الذات وفقدان الدافعية.

عوامل أسرية

- غياب الأب وما ترتب عليه من فراغ عاطفي وتربوي.
- انشغال الأم وقلة الوقت المخصص للمتابعة.
- تغيّر بيئة السكن والروتين اليومي.

عوامل مدرسية

- عدم إبلاغ المدرسة بظروف الفقد في حينه.
- تركيز بعض المواقف الصفية على موضوعات الأسرة والأب دون مراعاة.
- قلة الأنشطة الداعمة نفسياً في الفصل.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ر) من تراجع تحصيلي واضطراب انفعالي مؤقت (حزن وقلق انفصال) ناتج عن فقدان الوالد وتغيّر الظروف الأسرية، مع ضعف قنوات الدعم العاطفي في البيت والمدرسة، ولا تشير المعطيات إلى صعوبة تعلم أساسية.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
تهيئة بيئة صفية آمنة ومتفهمة	إطلاع المعلمات ذوات العلاقة بسرية على ظروف الطالبة، ومراعاة الموضوعات الحساسة في الحصص	الموجهة الطلابية والمعلمات	الأسبوع الأول	توقف نوبات البكاء داخل الحصص
تفريغ المشاعر وتقبّل الفقد	جلسات إرشاد فردي أسبوعية باستخدام الرسم والقصة العلاجية والحوار الداعم	الموجهة الطلابية	8 أسابيع	تعبير الطالبة عن مشاعرها لفظياً بصورة متزنة
إعادة الاندماج الاجتماعي	إشراكها في مجموعة تعاونية صغيرة، وتكليفها بمهمة محببة (مساعدة أمينة المكتبة / الإذاعة)	رائدة الفصل	6 أسابيع	مشاركتها في الأنشطة الجماعية مرتين أسبوعياً على الأقل
استعادة المستوى التحصيلي	خطة علاجية في الرياضيات والعلوم بأوراق عمل متدرجة وتعزيز فوري	معلمات المواد	فصل دراسي	رفع درجات الاختبارات القصيرة بنسبة 20% على الأقل

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
تفعيل الشراكة مع الأسرة	لقاء إرشادي مع الأم حول التعامل مع حزن الطفل، وتخصيص وقت يومي قصير للحوار	الموجهة الطلابية وولية الأمر	شهرياً	تقرير الأم عن تحسّن تواصل ابنتها في البيت
الدعم القيمي والإيماني	تعزيز معاني الصبر والرضا بأسلوب مناسب لعمرها، وتذكيرها بالدعاء للوالد	معلمة الدراسات الإسلامية	مستمر	ارتفاع مؤشرات الطمأنينة في جلسات الإرشاد

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	بدء الجلسات وتهيئة المعلمات	انخفاض نوبات البكاء من يومية إلى مرتين أسبوعياً
الأسبوع 3 إلى 4	دمج الطالبة في المجموعة التعاونية	مشاركة أولى في نشاط الإذاعة
الأسبوع 5 إلى 6	متابعة الخطة العلاجية للمواد	تحسن درجات الاختبارات القصيرة
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم شامل ولقاء ثانٍ مع الأم	استقرار انفعالي وعودة تدريجية للمستوى السابق

8 التوصيات

- إلزام أولياء الأمور عبر نموذج رسمي بإبلاغ المدرسة بالظروف الأسرية الطارئة (وفاة، انفصال، سفر طويل) بسرية تامة.
- إعداد قائمة سرية بالطالبات اللواتي يعشن غياب أحد الوالدين ومتابعتهن متابعة وقائية.
- تدريب المعلمات على مهارات التعامل مع الطفل الحزين وتجنب الموضوعات المؤلمة دون تمهيد.
- تنفيذ برنامج جماعي بعنوان (أمانٌ وطمأنينة) للطالبات في الظروف المشابهة.
- الإحالة إلى أخصائية نفسية بموافقة الأم إذا استمرت الأعراض بعد انتهاء الخطة.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأم (ولية الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **تقرير الأم عن تحسن تواصل ابنتها وانتظام نومها**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	إبلاغ الأم بملاحظات المدرسة بلطف، والتعزية، ودعوتها للقاء في وقت يناسب عملها.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	فهم ظروف الفقد والانتقال، وعرض التشخيص، والاتفاق على وقت حوار يومي قصير مع ابنتها.
أسبوعياً	رسالة متابعة قصيرة (الحالة الانفعالية + الواجبات)	رائدة الفصل والموجهة	تبادل الملاحظات بين البيت والمدرسة، وإشعار الأم بأي نوبة بكاء أو تحسن.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	مراجعة تقرير الأم عن تواصل ابنتها في البيت ومستوى درجاتها، وتعديل الخطة إن لزم.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	عرض النتائج، والاتفاق على المتابعة الوقائية، أو الإحالة لأخصائية نفسية بموافقة الأم.

مهام ولي الأمر في العلاج

- تخصيص 15 دقيقة يومياً للحوار مع ابنتها والاستماع لمشاعرها دون مقاطعة.
- طمأنة الطالبة بأن الأم باقية معها، والحفاظ على روتين يومي ثابت.
- متابعة الواجبات بالتنسيق مع الجدة، وتوقيع بطاقة المتابعة الأسبوعية.
- إبلاغ الموجهة بأي تغير في النوم أو الأكل أو المزاج.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	نجلاء الصخيري	ناديه عوض الصخيري

البحث التشخيصي – الحالة الثانية

2 ضعف مهارات القراءة والكتابة

المجال: **تعليمي – تحصيلي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالب (م)	**الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)**	**8 سنوات**
ترتيبه بين إخوته	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الأخير من خمسة	**معلمة لغتي**	**بعد نتائج الاختبار التشخيصي القبلي 1448هـ**

2 وصف المشكلة

أظهرت نتائج الاختبار التشخيصي القبلي في مادة لغتي أن الطالب (م) لم يتقن المهارات القرائية والكتابية المتوقعة لصفه؛ إذ يقرأ ببطء شديد بأسلوب التهجئة الحرفية، ويخلط بين الحروف المتشابهة رسماً وصوتاً، ويعجز عن كتابة كلمات بسيطة إملائياً، مما انعكس سلباً على تحصيله في بقية المواد التي تعتمد على القراءة.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- قراءة متقطعة بالتهجئة لا تتجاوز (12) كلمة في الدقيقة، والمتوقع لصفه (40 إلى 60) كلمة.
- الخلط بين الحروف المتشابهة (ب – ت – ث) و(ح – خ – ج) و(س – ص).
- حذف المدود وإبدال الحركات القصيرة بالطويلة والعكس.
- كتابة غير مقروءة مع عكس اتجاه بعض الحروف.
- تجنّب القراءة الجهرية والشعور بالخجل، والانسحاب من المشاركة في الحصة.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الاختبار التشخيصي	اختبار مهارات القراءة والكتابة للصف الثالث	إتقان 35% فقط من المهارات الأساسية
قياس الطلاقة القرائية	قراءة نص قصير مع حساب عدد الكلمات الصحيحة في الدقيقة	12 كلمة/دقيقة بدقة 60%
تحليل الأخطاء الكتابية	تحليل كراسة الإملاء والتعبير لشهر كامل	أخطاء متكررة في الحروف المتشابهة والمدود
مقابلة ولي الأمر	لقاء حضوري مع الأم	ضعف القراءة منذ الصف الأول، وقلة المتابعة المنزلية

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الفحص الصحي	فحص النظر والسمع عبر المرشدة الصحية	حاجة لفحص نظر تفصيلي – أُحيل للمركز الصحي
ملاحظة الأداء	ملاحظة الطالب في حصص لغتي والرياضيات	يفهم المسائل شفهياً ويعجز عند قراءتها

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية	عوامل أسرية	عوامل مدرسية
• فاقد تعليمي متراكم في المهارات الأساسية منذ الصف الأول. • ضعف الوعي الصوتي والتمييز السمعي بين الأصوات. • انخفاض الثقة بالنفس عند القراءة.	• انشغال الأسرة وغياب جلسات القراءة المنزلية. • عدم توفر قصص وكتب مناسبة لعمره في البيت. • الإفراط في استخدام الأجهزة على حساب القراءة.	• عدم اكتشاف الضعف مبكراً ومعالجته في الصفوف الأولى. • كثافة الفصل وقلة الوقت المخصص للعلاج الفردي. • اعتماد التقويم على الكتابة أكثر من الأداء الشفهي.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

يعاني الطالب (م) من ضعف قرائي وكتابي ناتج عن فاقد تعليمي متراكم في مهارات الوعي الصوتي وربط الصوت بالرمز، مع احتمال وجود ضعف بصري يستدعي الفحص، ولا يمكن الجزم بصعوبة تعلم نمائية إلا بعد تطبيق برنامج علاجي مكثف وإعادة القياس.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
التأكد من سلامة الحواس	إحالة لفحص النظر التفصيلي ومتابعة النتيجة مع الأسرة	المرشدة الصحية	أسبوعان	استلام تقرير الفحص وتنفيذ توصياته
تنمية الوعي الصوتي	تمارين يومية (10 دقائق) لتمييز الأصوات والمقاطع باستخدام البطاقات والألعاب اللغوية	معلمة لغتي	4 أسابيع	تمييز 90% من الحروف المتشابهة صوتياً
ربط الصوت بالرمز	برنامج (الحرف في الكلمة) بالبطاقات الملونة والكتابة على الرمل والسبورة الصغيرة	معلمة لغتي	6 أسابيع	كتابة كلمات ثلاثية وثنائية المقطع بدقة 80%
رفع الطلاقة القرائية	القراءة المتكررة لنصوص قصيرة، والقراءة المزدوجة مع زميل متمكن	معلمة لغتي ورائدة الفصل	8 أسابيع	الوصول إلى 35 كلمة/دقيقة
تعزيز الثقة والدافعية	لوحة إنجاز فردية ونجوم تقدم، وقراءته أمام مجموعة صغيرة قبل الفصل كاملاً	معلمة لغتي	مستمر	مبادرته بالقراءة الجهرية طوعاً

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
إشراك الأسرة	حقيبة قراءة منزلية أسبوعية وجدول متابعة يوقّعه ولي الأمر	الموجهة الطلابية وولي الأمر	أسبوعياً	انتظام توقيع الجدول بنسبة 80%

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	الفحص الصحي وتمارين الوعي الصوتي	تقرير النظر: يحتاج نظارة طبية – تم توفيرها
الأسبوع 3 إلى 4	برنامج ربط الصوت بالرمز	تحسّن تمييز الحروف المتشابهة إلى 75%
الأسبوع 5 إلى 6	القراءة المتكررة والمزدوجة	ارتفاع الطلاقة إلى 25 كلمة/دقيقة
الأسبوع 7 إلى 8	إعادة الاختبار التشخيصي	إتقان 65% من المهارات مقارنة بـ 35% في خط الأساس

8 التوصيات

- تطبيق الاختبار التشخيصي في المهارات الأساسية لجميع طلاب وطالبات الصفوف الأولية في الأسبوعين الأولين.
- تخصيص حصص علاجية أسبوعية ضمن مجموعات صغيرة متجانسة المستوى.
- الفحص الدوري للنظر والسمع لكل طالب يظهر ضعفاً قرائياً قبل بدء العلاج.
- تفعيل مبادرة (حقيبة القراءة المنزلية) وإشراك الأسر في برنامج القراءة.
- إحالة الحالة لمعلمة صعوبات التعلم إذا لم يتحقق التقدم المتوقع بعد إعادة القياس.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأم (ولية الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **انتظام توقيع جدول القراءة المنزلية بنسبة 80%**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	إبلاغ الأم بنتيجة الاختبار التشخيصي ودعوتها للقاء، وطلب إحضار أي تقرير طبي سابق للنظر.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	شرح مستوى الطالب بالأرقام، والاتفاق على فحص النظر، وتسليم حقيبة القراءة المنزلية وطريقة استخدامها.
أسبوعياً	جدول القراءة المنزلية الموقّع	رائدة الفصل والموجهة	استلام الجدول موقّعاً، وإرسال الكلمات الجديدة للأسبوع القادم.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	عرض تقدم الطلاقة القرائية (كلمة/دقيقة)، والتأكد من استخدام النظارة الطبية.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	عرض نتيجة إعادة الاختبار التشخيصي، والاتفاق على الاستمرار أو الإحالة لمعلمة صعوبات التعلم.

مهام ولي الأمر في العلاج

- الاستماع لقراءة الطالب 10 دقائق يومياً من حقيبة القراءة وتوقيع الجدول.
- مراجعة طبيب العيون في الموعد المحدد وإحضار التقرير.
- تقليل وقت الأجهزة واستبداله بقصص مصورة مناسبة لعمره.
- التشجيع والثناء على المحاولة لا على النتيجة فقط.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	عزة الزهراني	ناديه عوض الصخيري

المملكة العربية السعودية – وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

البحث التشخيصي – الحالة الثالثة

3 السلوك العدواني والتنمر على الزملاء

المجال: **سلوكي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي **الطالب (ع)**	الصف **الثالث الابتدائي (الطفولة المبكرة)**	العمر **9 سنوات**
ترتيبه بين إخوته **الأكبر من أربعة**	جهة الإحالة **وكيلة المدرسة وعدد من أولياء الأمور**	تاريخ الإحالة **الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

تكررت الشكاوى من زملاء الطالب (ع) وأولياء أمورهم بسبب اعتدائه عليهم بالضرب والدفع وأخذ أدواتهم بالقوة، إضافة إلى السخرية من بعضهم وإطلاق ألقاب جارحة عليهم، وتركّز ذلك في أوقات الفسحة والانصراف وحصص النشاط. وقد سُجلت عليه عدة مخالفات سلوكية في سجل السلوك خلال شهر واحد.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- الاعتداء الجسدي على الزملاء (ضرب، دفع، عرقلة) بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعياً.
- التنمر اللفظي: السخرية والألقاب الجارحة والتهديد.
- أخذ أدوات الزملاء ووجباتهم دون إذن.
- عدم الالتزام بتوجيهات المعلمات والرد عليهن بانفعال.
- التفاخر بالقوة وتشكيل مجموعة صغيرة من الزملاء يقودها في الفسحة.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
سجل السلوك	مراجعة المخالفات المسجلة خلال الشهر	7 مخالفات من الدرجة الثانية والثالثة
الملاحظة المنظمة	بطاقة رصد تكرار السلوك وتوقيته ومثيراته لمدة أسبوعين	75% من الحوادث في الفسحة والانصراف
مقابلة الطالب	جلستان فرديتان	يرى أن الضرب وسيلة لـ(أخذ الحق) وكسب الاحترام
مقابلة ولي الأمر	لقاء حضوري مع الأب	أسلوب تربية يعتمد على العقاب البدني، ومشاهدة ألعاب عنيفة

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
استطلاع الزملاء	أسئلة بسيطة سرية لعينة من زملاء الفصل	شعور عدد من الزملاء بالخوف منه
تقارير المعلمات	استمارة رصد من 4 معلمات	سلوك أهدأ في الحصص المنظمة والمحفزة

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- ضعف مهارات ضبط الانفعال وحل المشكلات.
- الرغبة في لفت الانتباه وإثبات الذات.
- طاقة حركية عالية غير موجّهة.

عوامل أسرية

- الاعتماد على العقاب البدني أسلوباً تربوياً.
- مشاهدة الألعاب والمقاطع العنيفة دون رقابة.
- تحميله مسؤولية إخوته الصغار بأسلوب السيطرة.

عوامل مدرسية

- قلة الإشراف في بعض مواقع الفسحة والانصراف.
- عدم وجود أنشطة تفرّغ الطاقة في أوقات الفراغ.
- تأخر الحزم في تطبيق الإجراءات السلوكية المتدرجة.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

يعاني الطالب (ع) من سلوك عدواني وتنمر متكرر ناتج عن نمذجة أساليب عنيفة في البيئة الأسرية والإعلامية، وضعف مهارات ضبط الانفعال، مع ثغرات في الإشراف المدرسي أثناء أوقات الفراغ؛ وهو سلوك مكتسب قابل للتعديل.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
حماية الزملاء وضبط البيئة	تكثيف الإشراف في الفسحة والانصراف وتحديد مواقع آمنة، وتطبيق الإجراءات المتدرجة وفق قواعد السلوك والمواظبة	الوكيلة والمشرفات	فوري ومستمر	انخفاض الحوادث المسجلة بنسبة 50% خلال شهر
تعليم ضبط الانفعال	تدريب على أسلوب (توقّف – تنفّس – فكّر – تصرّف) عبر لعب الأدوار والقصص	الموجهة الطلابية	6 جلسات	استخدامه الأسلوب في موقفين موثقين
تعديل السلوك بالعقد السلوكي	عقد سلوكي مكتوب بين الطالب والموجهة وولي الأمر بأهداف يومية ومكافآت متفق عليها	الموجهة الطلابية	8 أسابيع	تحقيق أهداف العقد 4 أيام من 5
توجيه الطاقة إيجابياً	إسناد دور قيادي إيجابي (قائد فريق النظام / مساعد معلمة التربية البدنية)	معلمة التربية البدنية	فصل دراسي	التزامه بالدور دون مخالفات
بناء التعاطف وإصلاح العلاقة	جلسة إصلاحية مع الزملاء المتضررين بإشراف الموجهة، وتكليفه بعمل تعاوني معهم	الموجهة الطلابية	أسبوعان	اعتذار الطالب وتحسن علاقته بزملائه

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الشراكة الأسرية	توعية ولي الأمر ببدائل العقاب البدني، وتنظيم وقت الأجهزة والمحتوى المشاهد	الموجهة وولي الأمر	لقاءان	التزام الأسرة ببطاقة المتابعة المنزلية

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	ضبط الإشراف وتوقيع العقد السلوكي	انخفاض الاعتداء الجسدي إلى مرة واحدة أسبوعياً
الأسبوع 3 إلى 4	جلسات ضبط الانفعال والدور القيادي	لم تُسجل حوادث تنمر لفظي
الأسبوع 5 إلى 6	الجلسة الإصلاحية والعمل التعاوني	تحسن ملحوظ في علاقته بزملائه
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم العقد ولقاء ولي الأمر	تحقيق أهداف العقد بنسبة 85%

8 التوصيات

- تنفيذ برنامج وقائي مدرسي لمكافحة التنمر يشمل جميع الصفوف وأسبوعاً توعوياً سنوياً.
- إعداد خريطة إشراف للمواقع الحرجة في الفسحة والانصراف ومراجعتها شهرياً.
- توفير أنشطة حركية منظمة أثناء الفسحة لتفريغ الطاقة.
- تفعيل صندوق سري للإبلاغ عن التنمر يتابعه فريق التوجيه.
- الإحالة لوحدة الخدمات الإرشادية إذا عاد السلوك بعد إغلاق الحالة.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأب (ولي الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **التزام الأسرة ببطاقة المتابعة المنزلية وانخفاض الشكاوى**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	إبلاغ الأب بتكرار السلوك بموضوعية ودون تهويل، ودعوته للقاء عاجل.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	عرض سجل الملاحظات، وتوقيع العقد السلوكي الثلاثي، والاتفاق على بدائل العقاب البدني وضبط الألعاب العنيفة.
أسبوعياً	بطاقة العقد السلوكي الأسبوعية	رائدة الفصل والموجهة	إرسال نتيجة العقد الأسبوعية للأب، والاتفاق على المكافأة المنزلية عند تحقق الأهداف.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	مراجعة انخفاض الحوادث، ومدى التزام البيت ببدائل العقاب وتنظيم الأجهزة.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	تقويم العقد، وتكريم الطالب بحضور الأب، والاتفاق على المتابعة الوقائية.

مهام ولي الأمر في العلاج

- الالتزام بالعقد السلوكي وتقديم المكافأة المتفق عليها عند تحقق الأهداف.
- استبدال العقاب البدني بالحرمان المؤقت من الامتيازات والحوار.
- منع الألعاب والمقاطع العنيفة وتحديد وقت الأجهزة.
- تكليف الطالب بمسؤوليات منزلية إيجابية والثناء عليه أمام إخوته.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	غزيل العتيبي	ناديه عوض الصخيري

4

البحث التشخيصي – الحالة الرابعة

الانطواء والخجل الاجتماعي

المجال: **نفسي – اجتماعي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالبة (ن)	**الثاني الابتدائي**	**7 سنوات**
ترتيبها بين إخوتها	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الوحيدة	**رائدة الفصل**	**الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

تلاحظ رائدة الفصل أن الطالبة (ن) لا تتحدث داخل الفصل إلا نادراً وبصوت منخفض جداً، وتتجنب الإجابة الشفهية ولو كانت تعرف الإجابة، وتقضي وقت الفسحة منفردة قرب باب الفصل. وعلى الرغم من ذلك فإن أداءها الكتابي جيد، وتؤكد والدتها أنها تتحدث بطلاقة وحيوية في البيت.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- الصمت شبه التام في الفصل والإجابة بالإيماء أو الكتابة.
- احمرار الوجه وارتجاف الصوت عند توجيه سؤال مباشر إليها.
- قضاء الفسحة وحيدة وعدم وجود صديقة مقربة.
- رفض المشاركة في الإذاعة والأنشطة أمام الآخرين.
- أداء كتابي جيد يدل على فهم المحتوى وتمكّنها منه.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملاحظة المنظمة	رصد مرات المبادرة بالكلام والتفاعل لمدة أسبوعين	مبادرة واحدة فقط بالكلام خلال الأسبوعين
مقابلة الطالبة	جلسات فردية بالدمى والرسم واللعب	تتحدث بصوت أوضح في الجلسات الفردية بعد الألفة
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	طفلة وحيدة، قليلة الاختلاط بالأطفال، وحماية زائدة من الأسرة
تقارير المعلمات	استمارة رصد مختصرة	أداء كتابي جيد ومشاركة شفهية معدومة

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الرسم الحر	رسم (أنا في المدرسة)	رسمت نفسها صغيرة جداً في زاوية الصفحة
السجلات المدرسية	الحضور والتحصيل	حضور منتظم وتحصيل كتابي جيد جداً

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- طبع خجول وحساسية زائدة للتقييم.
- ضعف المهارات الاجتماعية والمبادرة.
- الخوف من الخطأ أمام الآخرين.

عوامل أسرية

- كونها الطفلة الوحيدة وقلة اختلاطها بالأقران.
- الحماية الزائدة وقيام الأسرة بالأدوار نيابة عنها.
- قلة الزيارات والأنشطة الاجتماعية خارج المنزل.

عوامل مدرسية

- التركيز على المشاركة الشفهية أمام الفصل كاملاً.
- قلة العمل في مجموعات صغيرة.
- تعليقات زميلات على صمتها أشعرتها بالحرج.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ن) من خجل اجتماعي وانطواء في البيئة المدرسية، ناتج عن طبع حساس وقلة الخبرات الاجتماعية والحماية الزائدة، مع مواقف صفية ضاغطة؛ ويُرصد الصمت الانتقائي احتمالاً يستلزم المتابعة إذا استمر رغم التدخل.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
بناء الألفة والأمان	جلسات فردية قصيرة باللعب والدمى، والتواصل اللطيف دون ضغط للكلام	الموجهة الطلابية	3 أسابيع	حديثها مع الموجهة بصوت مسموع
التدرج في المشاركة	سلّم تدريجي: إجابة كتابية ← همس للمعلمة ← إجابة لزميلة ← إجابة لمجموعة ← إجابة للفصل	رائدة الفصل	8 أسابيع	إجابة شفهية واحدة أمام الفصل أسبوعياً
تكوين صداقة داعمة	إقرانها بزميلة ودودة (الصديقة الرفيقة) في الفسحة والأنشطة	رائدة الفصل	6 أسابيع	قضاء الفسحة مع زميلة 4 أيام من 5
تنمية الثقة بالنفس	مهام قيادية بسيطة غير كلامية (توزيع الأوراق، مسؤولة الركن)، وإبراز إنجازاتها الكتابية	معلمات الفصل	مستمر	مبادرتها بطلب مهمة
ضبط البيئة الصفية	منع التعليقات على صمتها، وتعزيز ثقافة التقبل في الفصل	رائدة الفصل	فوري	عدم تكرار التعليقات السلبية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الشراكة الأسرية	توجيه الأسرة لتقليل الحماية الزائدة وإتاحة لقاءات منظمة مع أقرانها خارج المدرسة	الموجهة وولية الأمر	شهرياً	مشاركتها في نشاط اجتماعي خارجي

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	جلسات الألفة الفردية	بدأت تتحدث مع الموجهة بصوت منخفض
الأسبوع 3 إلى 4	الصديقة الرفيقة والمهام غير الكلامية	قضاء الفسحة مع زميلتها الرفيقة
الأسبوع 5 إلى 6	التدرج في المشاركة	أجابت لمجموعتها الصغيرة شفهياً
الأسبوع 7 إلى 8	التقويم ولقاء الأسرة	أول إجابة شفهية أمام الفصل كاملاً

8 التوصيات

- تنويع أساليب المشاركة الصفية لتشمل الكتابة والعمل في مجموعات صغيرة وعدم حصرها في الإجابة الجهرية.
- تنفيذ برنامج (الصديقة الرفيقة) لدعم الطالبات الجدد والخجولات.
- تدريب المعلمات على التمييز بين الخجل الطبيعي والصمت الانتقائي.
- إشراك الطالبات الخجولات في أنشطة فنية وكتابية تبرز قدراتهن.
- الإحالة لأخصائية نفسية إذا استمر الصمت داخل المدرسة بعد فصل دراسي من التدخل.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأم (ولية الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **مشاركة الطالبة في نشاط اجتماعي خارج المدرسة**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	طمأنة الأم بأن الهدف دعم ابنتها لا تصنيفها، ودعوتها للقاء.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	مقارنة سلوك الطالبة في البيت والمدرسة، والاتفاق على تقليل الحماية الزائدة وإتاحة لقاءات مع أقرانها.
أسبوعياً	رسالة إنجاز أسبوعية (موقف شجاع هذا الأسبوع)	رائدة الفصل والموجهة	إرسال كل مبادرة كلامية تحققت في المدرسة ليتم الثناء عليها في البيت.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	مراجعة تقدم سلّم المشاركة ومشاركتها في نشاط اجتماعي خارجي.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	عرض النتائج، والإحالة لأخصائية نفسية إذا استمر الصمت داخل المدرسة.

مهام ولي الأمر في العلاج

- ترتيب لقاء أسبوعي للطالبة مع زميلتها الرفيقة أو أقارب من عمرها.
- ترك الطالبة تطلب احتياجاتها بنفسها (في المحل، من المعلمة) دون أن تتكلم الأم عنها.
- الثناء على كل مبادرة كلامية دون ضغط أو مقارنة بالآخرين.
- تجنب وصفها بـ(الخجولة) أمامها أو أمام الآخرين.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	هلا العتيبي	ناديه عوض الصخيري

5

البحث التشخيصي – الحالة الخامسة

التأخر الصباحي والغياب المتكرر

المجال: **انضباطي – أسري** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالبة (ه)	**السادس الابتدائي**	**12 سنة**
ترتيبها بين إخوتها	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الكبرى من ستة	**وكيلة المدرسة**	**نهاية الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

أظهر نظام نور وسجل المتابعة اليومية تكرار تأخر الطالبة (ه) عن الطابور الصباحي وبداية الحصة الأولى، إضافة إلى غيابها أياماً متفرقة دون عذر مقبول، خاصة أيام الأحد والخميس. وقد انعكس ذلك على فقدها لعدد من الدروس والتقويمات، وتراجع مستواها في الرياضيات والعلوم.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- التأخر الصباحي 11 مرة خلال شهر واحد بمعدل 15 إلى 30 دقيقة.
- الغياب 5 أيام متفرقة بدون عذر، ثلاثة منها يومي أحد وخميس.
- الحضور بمظهر يدل على قلة النوم والإرهاق.
- فقد عدد من التقويمات القصيرة وعدم تسليم بعض المهام.
- تبريرات متكررة: (ما صحيت)، (ما فيه أحد يوصلني).

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
سجلات الحضور	تحليل بيانات نور وسجل التأخر لشهرين	نمط واضح في بداية ونهاية الأسبوع
مقابلة الطالبة	جلستان فرديتان	سهر على الجوال، ومساعدتها في رعاية إخوتها صباحاً
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	ظروف عمل الأب ومواعيد المواصلات غير منتظمة
استبانة العادات اليومية	جدول نوم وأنشطة لأسبوع تعبّئه الطالبة	متوسط النوم 6 ساعات فقط

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
تقارير المعلمات	استمارة رصد	فاقد في دروس الحصة الأولى بشكل خاص
السجل الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	لا توجد أعذار صحية مسجلة

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- السهر واضطراب مواعيد النوم.
- ضعف الإحساس بأهمية الانضباط وأثر الغياب.
- قلة الدافعية للحصص الأولى.

عوامل أسرية

- عدم انتظام وسيلة النقل.
- تحميلها أعباء رعاية الإخوة الصغار صباحاً.
- تساهل الأسرة في الغياب بنهاية الأسبوع.

عوامل مدرسية

- تأخر التواصل مع الأسرة في بداية تكرار التأخر.
- غياب التحفيز للانضباط وقلة الأنشطة الجاذبة صباحاً.
- عدم ربط الحضور بنتائج التحصيل أمام الطالبة.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ه) من تأخر صباحي وغياب متكرر بدون عذر ناتج عن اضطراب نمط النوم والسهر على الأجهزة، وعدم انتظام وسيلة النقل، وتحميلها أعباء أسرية صباحية، مع تساهل أسري في الغياب وضعف التدخل المدرسي المبكر.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
التدخل الإداري المتدرج	تطبيق إجراءات قواعد السلوك والمواظبة بالتدرج، واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد	وكيلة المدرسة	فوري	توقيع التعهد والتزام الأسرة
تنظيم النوم والاستيقاظ	جدول نوم أسبوعي بالاتفاق مع الطالبة والأسرة، وإيقاف الجوال قبل النوم بساعة	الموجهة الطلابية	4 أسابيع	ارتفاع متوسط النوم إلى 8 ساعات
حل مشكلة النقل	التنسيق مع الأسرة لبديل نقل ثابت أو ضمها لمجموعة نقل منتظمة	الوكيلة وولي الأمر	أسبوعان	وصولها قبل الطابور 4 أيام من 5
التحفيز الإيجابي	بطاقة (منضبطة الأسبوع) ولوحة حضور شهرية ومكافأة للحضور التام	رائدة الفصل	فصل دراسي	حضور تام لمدة 4 أسابيع متتالية
تعويض الفاقد	خطة تعويضية لدروس الحصة الأولى في الرياضيات والعلوم	معلمات المواد	4 أسابيع	اجتياز التقويمات التعويضية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
تعزيز المسؤولية	تكليفها بمهمة صباحية (مساعدة في الطابور أو الإذاعة) تربطها بالحضور المبكر	مسؤولة النشاط	فصل دراسي	التزامها بالمهمة دون تأخر

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	استدعاء ولي الأمر وحل مشكلة النقل	انخفاض التأخر من 3 إلى مرة واحدة أسبوعياً
الأسبوع 3 إلى 4	جدول النوم والمهمة الصباحية	لم تُسجل حالات غياب بدون عذر
الأسبوع 5 إلى 6	التحفيز وخطة تعويض الفاقد	اجتياز تقويمين تعويضيين
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم شامل	حضور تام لأربعة أسابيع وحصولها على شهادة الانضباط

8 التوصيات

- الرصد اليومي للتأخر والغياب والتواصل مع الأسرة من أول تكرار لا من تراكمه.
- إطلاق مبادرة مدرسية للانضباط تتضمن تكريماً شهرياً للفصل الأعلى حضوراً.
- تنفيذ لقاء توعوي لأولياء الأمور حول أثر الغياب وأهمية النوم على التحصيل.
- جعل الحصة الأولى والطابور أكثر جاذبية بأنشطة قصيرة محفزة.
- تحليل بيانات الغياب شهرياً لاكتشاف الأنماط (أيام بعينها) ومعالجتها جماعياً.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأب (ولي الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **وصول الطالبة قبل الطابور 4 أيام من 5**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	إبلاغ الأب بعدد مرات التأخر والغياب من واقع نظام نور، ودعوته للقاء.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	توقيع التعهد، والاتفاق على بديل نقل ثابت، وجدول نوم، وتخفيف أعباء رعاية الإخوة صباحاً.
أسبوعياً	رسالة حضور أسبوعية من واقع نور	رائدة الفصل والموجهة	إرسال سجل الحضور والتأخر للأسبوع وإشعار فوري يوم الغياب.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	مراجعة انتظام النقل والنوم وأثرهما على الحضور.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	عرض أربعة أسابيع حضور تام، وتسليم شهادة الانضباط بحضور ولي الأمر.

مهام ولي الأمر في العلاج

- توفير وسيلة نقل ثابتة تصل قبل الطابور.
- تطبيق جدول النوم وإبعاد الجوال قبل النوم بساعة.
- إعفاء الطالبة من مهام رعاية إخوتها صباحاً.
- عدم السماح بالغياب إلا بعذر موثق وإبلاغ المدرسة مسبقاً.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	أبرار الطلحي	ناديه عوض الصخيري

6

البحث التشخيصي – الحالة السادسة

تشتت الانتباه وفرط الحركة

المجال: **سلوكي – تعليمي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالب (ف)	**الأول الابتدائي (الطفولة المبكرة)**	**6 سنوات ونصف**
ترتيبه بين إخوته	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الثاني من ثلاثة	**معلمة الصف**	**الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

تشير معلمة الصف إلى أن الطالب (ف) لا يستطيع البقاء في مقعده أكثر من دقائق معدودة، ويتنقل في الفصل ويقاطع المعلمة وزملاءه باستمرار، ولا يكمل المهام المطلوبة منه، وينسى أدواته ويفقدها بشكل يومي، رغم أنه ذكي ويستوعب بسرعة عندما يُعطى انتباهه. وتؤكد الأسرة ظهور هذه السمات في البيت منذ مرحلة الروضة.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- مغادرة المقعد بمعدل 8 إلى 10 مرات في الحصة الواحدة.
- عدم القدرة على التركيز في المهمة أكثر من 3 إلى 5 دقائق.
- المقاطعة المستمرة والإجابة قبل اكتمال السؤال.
- عدم إكمال الأعمال الكتابية ونسيان الأدوات وفقدها يومياً.
- اندفاعية في الحركة أدت لحوادث بسيطة مع زملائه دون قصد الإيذاء.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملاحظة المنظمة	رصد تكرار مغادرة المقعد ومدة التركيز في 10 حصص	متوسط 9 مرات مغادرة، وتركيز 4 دقائق
قائمة تقدير السلوك	قائمة رصد للسمات تعبّئها المعلمة والأسرة (للاسترشاد لا للتشخيص)	تطابق السمات في البيئتين المدرسية والمنزلية
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	السمات واضحة منذ عمر 4 سنوات، وتأخر في النوم
ملاحظة الأداء	مقارنة أداء المهام القصيرة بالطويلة	إنجاز ممتاز في المهام القصيرة المصحوبة بحركة

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملف الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	لا توجد ملاحظات مسجلة، والسمع والنظر سليمان
تقارير المعلمات	استمارة رصد من 3 معلمات	النمط ذاته في جميع الحصص

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية

- سمات اندفاعية وحركية عالية ظاهرة منذ سن مبكرة.
- صعوبة تنظيم الذات والانتباه المستمر.
- احتمال وجود عامل نمائي يستلزم تقييماً متخصصاً.

عوامل أسرية

- عدم انتظام مواعيد النوم.
- الاستخدام المطوّل للأجهزة ذات المثيرات السريعة.
- عدم وجود روتين منزلي ثابت للمهام.

عوامل مدرسية

- طول المهام الصفية مقارنة بقدرته على التركيز.
- جلوسه في موقع كثير المشتتات قرب النافذة والباب.
- قلة الفواصل الحركية المنظمة أثناء الحصة.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تُظهر المعطيات لدى الطالب (ف) مؤشرات تشتت انتباه وفرط حركة واندفاعية تظهر في أكثر من بيئة ومنذ عمر مبكر، مما يستدعي الإحالة لجهة طبية متخصصة لتقييمها؛ والدور المدرسي هنا تربوي داعم ولا يُعد تشخيصاً طبياً.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الإحالة للتقييم المتخصص	توجيه الأسرة بخطاب رسمي لعرض الطفل على طبيب أطفال نمائي / مختص بموافقتها	الموجهة الطلابية	أسبوعان	استلام تقرير الجهة المختصة
تهيئة البيئة الصفية	إجلاسه قرب المعلمة بعيداً عن المشتتات، وتقليل المثيرات على طاولته	معلمة الصف	فوري	انخفاض مرات مغادرة المقعد بنسبة 30%
تجزئة المهام	تقسيم المهمة إلى أجزاء قصيرة (5 دقائق) مع مؤقت مرئي وتعزيز فوري بعد كل جزء	معلمات الفصل	مستمر	إكمال 70% من المهام الصفية
فواصل حركية منظمة	تكليفه بمهام حركية مفيدة (توزيع، مسح السبورة) وفاصل حركي قصير كل 15 دقيقة	معلمة الصف	مستمر	انخفاض المقاطعة والتنقل غير المنظم
نظام تعزيز رمزي	بطاقة نجوم يومية لسلوكين محددين فقط (البقاء في المقعد – رفع اليد) تُستبدل بمكافأة	معلمة الصف	8 أسابيع	تحقيق السلوكين في 4 حصص يومياً

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الشراكة الأسرية	روتين منزلي ثابت للنوم والواجب، وتقليل الأجهزة، ودفتر تواصل يومي	الموجهة وولية الأمر	مستمر	انتظام دفتر التواصل بنسبة 80%

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	الإحالة وتهيئة البيئة الصفية	انخفاض مغادرة المقعد إلى 6 مرات في الحصة
الأسبوع 3 إلى 4	تجزئة المهام والفواصل الحركية	ارتفاع إنجاز المهام إلى 55%
الأسبوع 5 إلى 6	التعزيز الرمزي ومتابعة الأسرة	انخفاض المقاطعة بشكل واضح
الأسبوع 7 إلى 8	التقويم ومراجعة تقرير الجهة المختصة	إنجاز 70% من المهام وتعديل الخطة وفق توصيات المختص

8 التوصيات

- تدريب المعلمات على استراتيجيات إدارة الصف مع المتعلمين كثيري الحركة والتشتت.
- عدم وصف أي متعلم بـ(فرط الحركة) أمام الآخرين أو في المراسلات قبل صدور تقرير طبي.
- توفير أدوات بسيطة مساعدة (مؤقت مرئي، بطاقات خطوات، ركن هادئ).
- التنسيق مع برنامج صعوبات التعلم والتربية الخاصة عند ثبوت الحاجة.
- إعداد خطة تربوية فردية بعد استلام تقرير الجهة المختصة وتحديثها كل فصل.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأم (ولية الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **انتظام دفتر التواصل بنسبة 80%**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	إبلاغ الأم بالملاحظات السلوكية بموضوعية دون استخدام مسميات تشخيصية، ودعوتها للقاء.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	تعبئة قائمة الرصد من البيت، وتسليم خطاب الإحالة للتقييم المتخصص، والاتفاق على دفتر التواصل اليومي.
أسبوعياً	دفتر التواصل اليومي	رائدة الفصل والموجهة	تسجيل نجوم السلوكين المستهدفين يومياً، وملاحظة البيت على النوم والواجب.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	متابعة موعد التقييم المتخصص، ومراجعة انتظام الروتين المنزلي.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	استلام تقرير الجهة المختصة، وإعداد الخطة التربوية الفردية بمشاركة الأم.

مهام ولي الأمر في العلاج

- حجز موعد التقييم لدى طبيب أطفال نمائي وإحضار التقرير.
- تثبيت روتين يومي للنوم والواجب بفترات قصيرة وفواصل حركية.
- تقليل الأجهزة ذات المثيرات السريعة.
- الاطلاع اليومي على دفتر التواصل وتعزيز النجاحات.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	نجود الزهراني	ناديه عوض الصخيري

البحث التشخيصي – الحالة السابعة

7 الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية

المجال: **سلوكي – صحي** | العام الدراسي: **1448هـ** | مستوى السرية: **سري**

1 بيانات الحالة

الاسم الرمزي	الصف	العمر
الطالبة (ج)	**الخامس الابتدائي**	**10 سنوات**
ترتيبها بين إخوتها	جهة الإحالة	تاريخ الإحالة
الثالثة من أربعة	**معلمة العلوم ورائدة الفصل**	**الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

2 وصف المشكلة

لاحظت المعلمات أن الطالبة (ج) تحضر مرهقة وتغفو أحياناً في الحصص، وأن حديثها مع زميلاتها يدور غالباً حول الألعاب الإلكترونية ومقاطع المنصات، وتراجع مستواها وتأخرت في تسليم الواجبات. وبيّنت المقابلة أنها تمتلك جهازاً خاصاً وتستخدمه لساعات طويلة يومياً، بما في ذلك ساعات متأخرة من الليل، مع ضعف في الرقابة على المحتوى.

المظاهر السلوكية الملاحظة:

- استخدام الجهاز بمعدل 6 إلى 7 ساعات يومياً، وحتى منتصف الليل أحياناً.
- النعاس والإرهاق وضعف التركيز في الحصص الأولى.
- تراجع المعدل وتأخر تسليم الواجبات والمشاريع.
- الانفعال الشديد عند الحديث عن تقليل وقت الجهاز.
- ضعف المشاركة في الأنشطة الحركية والتفاعل المباشر مع الزميلات.

3 أدوات التشخيص وجمع المعلومات

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
مقابلة الطالبة	جلستان فرديتان	تستخدم الجهاز للألعاب والمقاطع وتشعر بالملل بدونه
مقابلة ولية الأمر	لقاء حضوري	لا توجد ضوابط زمنية، والجهاز معها في غرفة النوم
استبانة العادات الرقمية	جدول استخدام يومي لأسبوع تعبّئه الطالبة مع الأسرة	متوسط 6.5 ساعات يومياً
تقارير المعلمات	استمارة رصد من 4 معلمات	إرهاق وتراجع في الواجبات والمشاريع

الأداة	الإجراء المنفّذ	أبرز النتائج
الملف الصحي	مراجعة مع المرشدة الصحية	شكوى من إجهاد العين وصداع متكرر
السجلات المدرسية	مقارنة الدرجات بالعام الماضي	انخفاض المعدل في 4 مواد

4 تحليل أسباب المشكلة

عوامل ذاتية	عوامل أسرية	عوامل مدرسية
• الانجذاب للمكافأة السريعة في الألعاب والمقاطع. • قلة الهوايات والأنشطة البديلة. • ضعف مهارة تنظيم الوقت.	• امتلاك جهاز خاص دون ضوابط زمنية أو رقابة على المحتوى. • وجود الجهاز في غرفة النوم. • انشغال الأسرة واستخدام الجهاز وسيلة إلهاء.	• قلة برامج التوعية بالمواطنة الرقمية للمرحلة. • قلة الأنشطة اللاصفية الجاذبة. • عدم التواصل المبكر مع الأسرة عند ظهور الإرهاق.

5 التشخيص

العبارة التشخيصية

تعاني الطالبة (ج) من إفراط في استخدام الأجهزة الذكية أثّر على نومها وصحتها وتحصيلها وعلاقاتها الاجتماعية، ناتج عن غياب الضوابط الأسرية وقلة البدائل والأنشطة الهادفة وضعف مهارات تنظيم الوقت.

6 الخطة العلاجية

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
الاتفاق الأسري الرقمي	إعداد ميثاق استخدام بين الطالبة والأسرة: ساعتان يومياً كحد أعلى، ولا جهاز في غرفة النوم	الموجهة وولية الأمر	الأسبوع الأول	التزام الأسرة بالميثاق الموقّع

الهدف	الإجراءات	المسؤول	المدة	مؤشر النجاح
ضبط المحتوى والوقت	تفعيل أدوات الرقابة الأبوية ومؤقت الاستخدام بإرشاد الأسرة	ولية الأمر	أسبوعان	انخفاض الاستخدام إلى 3 ساعات ثم ساعتين
بدائل جاذبة	إشراكها في نادي العلوم أو الفن أو القراءة، واكتشاف هواية حقيقية	مسؤولة النشاط	فصل دراسي	انتظامها في نشاط أسبوعي
التوعية الصحية	جلسة مع المرشدة الصحية عن النوم وصحة العين وقاعدة 20–20–20	المرشدة الصحية	جلستان	تحسّن الإرهاق والصداع
مهارات تنظيم الوقت	تدريبها على جدول يومي متوازن (دراسة – نشاط – أسرة – جهاز)	الموجهة الطلابية	4 جلسات	التزامها بالجدول 5 أيام أسبوعياً
استعادة التحصيل	خطة لتسليم الواجبات المتأخرة ومتابعة أسبوعية للمشاريع	رائدة الفصل والمعلمات	6 أسابيع	تسليم جميع الواجبات في وقتها

7 المتابعة والتقويم

الفترة	ما تم تنفيذه	النتيجة المتحققة
الأسبوع 1 إلى 2	توقيع الميثاق وضبط الأدوات	انخفاض الاستخدام إلى 4 ساعات يومياً
الأسبوع 3 إلى 4	التوعية الصحية والنادي	اختفاء النعاس في الحصص الأولى
الأسبوع 5 إلى 6	تنظيم الوقت واستعادة التحصيل	تسليم الواجبات في وقتها
الأسبوع 7 إلى 8	تقويم شامل ولقاء الأسرة	الالتزام بساعتين يومياً وتحسن المعدل

8 التوصيات

- تنفيذ برنامج سنوي للمواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للأجهزة لطالبات المرحلة.
- إصدار دليل مختصر لأولياء الأمور عن الضوابط الرقمية المناسبة لكل عمر.
- التوسع في الأندية والأنشطة اللاصفية بوصفها بدائل جاذبة.
- رصد مؤشرات الإرهاق والنعاس صباحاً والتواصل المبكر مع الأسرة.
- تضمين موضوع التوازن الرقمي في حصص النشاط والإذاعة المدرسية.

9 الشراكة مع ولي الأمر ومتابعة مديرة المدرسة

ولي الأمر: **الأم (ولية الأمر)** | مؤشر النجاح المنزلي: **الالتزام بساعتين يومياً كحد أعلى**

خطة التواصل مع ولي الأمر

المرحلة	نوع التواصل	المسؤولة	الهدف والمخرج
الأسبوع الأول	اتصال هاتفي ودعوة لقاء	الموجهة الطلابية	إبلاغ الأم بملاحظات الإرهاق والتراجع، ودعوتها للقاء مع الطالبة.
الأسبوع الأول	لقاء حضوري أول برئاسة مديرة المدرسة	مديرة المدرسة والموجهة	صياغة الميثاق الرقمي الأسري وتوقيعه من الطالبة والأم بحضور مديرة المدرسة.
أسبوعياً	رسالة متابعة رقمية (ساعات الاستخدام + الواجبات)	رائدة الفصل والموجهة	مطابقة ساعات الاستخدام في البيت مع حالة الطالبة في المدرسة.
الأسبوع الرابع	لقاء منتصف الخطة (حضوري أو عن بعد)	مديرة المدرسة والموجهة	مراجعة الالتزام بالساعتين يومياً وتفعيل الرقابة الأبوية.
الأسبوع الثامن	لقاء ختامي وتقويم مشترك	مديرة المدرسة والموجهة ورائدة الفصل	عرض تحسن المعدل والنوم، والاتفاق على استمرار الميثاق.

مهام ولي الأمر في العلاج

- تطبيق الميثاق الرقمي: ساعتان يومياً كحد أعلى، ولا جهاز في غرفة النوم.
- تفعيل أدوات الرقابة الأبوية ومؤقت الاستخدام.
- إتاحة بدائل (نادٍ، هواية، نشاط أسري أسبوعي).
- الحوار مع الطالبة عن عالمها الرقمي بدل المنع المفاجئ.

متابعة مديرة المدرسة

- ترؤس اللقاء الأول مع ولي الأمر، وعرض نتائج التشخيص بلغة داعمة غير اتهامية، واعتماد الخطة المشتركة.
- مراجعة سجل التواصل وتقدم الحالة مع الموجهة الطلابية كل أسبوعين وتوقيع المراجعة.
- ترؤس لقاء منتصف الخطة واللقاء الختامي، واتخاذ قرار الإغلاق أو التعديل أو الإحالة.

إقرار ولي الأمر: اطلعتُ على نتائج التشخيص والخطة العلاجية، وألتزم بتنفيذ المهام المسندة إليّ والتواصل المنتظم مع المدرسة.

اسم ولي الأمر: ..... التوقيع: ..... التاريخ: ...../...../1448هـ

الموجهة الطلابية	رائدة الفصل	مديرة المدرسة
هند العتيبي	نجلاء الصخيري	ناديه عوض الصخيري

نماذج التواصل مع أولياء الأمور

نموذجان موحّدان يُستخدمان مع جميع الحالات، ويُحفظان في ملف الحالة السري لدى الموجهة الطلابية، وتراجعهما مديرة المدرسة كل أسبوعين.

1 سجل التواصل مع ولي الأمر

الحالة (الاسم الرمزي): ..... الصف: ..... ولي الأمر: .....

م	التاريخ	نوع التواصل	القائمة بالتواصل	ملخص التواصل	النتيجة / الاتفاق	توقيع
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

نوع التواصل: اتصال هاتفي – رسالة – لقاء حضوري – لقاء عن بعد – زيارة. مراجعة مديرة المدرسة: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

2 محضر لقاء ولي الأمر

التاريخ: ...../...../1448هـ نوع اللقاء: ☐ أول ☐ منتصف الخطة ☐ ختامي المكان: .....

الحالة (الاسم الرمزي) والصف:

الحضور:

ملخص التشخيص المعروض:

ما اتفق عليه (مهام المدرسة):

ما اتفق عليه (مهام ولي الأمر):

موعد اللقاء القادم:

ولي الأمر	الموجهة الطلابية	مديرة المدرسة (رئيسة اللقاء)
الاسم والتوقيع	هند العتيبي التوقيع	ناديه عوض الصخيري التوقيع

بحث إجرائي – التطوير المهني والبيئة المدرسية

بحث إجرائي: الكتابة على الطاولات والجدران

تاريخ الإعداد: **28 ربيع الآخر 1448هـ** | الموافق: **9 أكتوبر 2026م** | المدة: **جمادى الأولى – شعبان 1448هـ**

المدرسة	مدة البحث	إشراف
الابتدائية السابعة والستون بالطائف	**جمادى الأولى – شعبان 1448هـ**	**مديرة المدرسة ناديه عوض الصخيري**
رئيسة فريق البحث	عضوات الفريق	الفئة المستهدفة
وكيلة المدرسة ثرياء القثامي	**منسقة الأمن والسلامة صالحة السهيمي، الموجهة الطلابية هند العتيبي، رائدة النشاط عيشة الحارثي**	**طلبة الصفوف من الأول إلى السادس**

المؤشرات المرتبطة	تاريخ الإعداد
1-4-1-2 · 4-1-1-3 · 4-2-1-3 · 3-2-1-5	**28/4/1448هـ**

هدف البحث

الحد من ظاهرة الكتابة والرسم على الطاولات والجدران في الفصول، وتعزيز انتماء الطلبة ومحافظتهم على ممتلكات المدرسة، والوصول إلى فصول نظيفة ومحفزة للتعلم.

سؤال البحث

ما أثر برنامج توعوي وتحفيزي يشارك فيه الطلبة والمعلمات وأولياء الأمور في خفض عدد الطاولات والجدران المتضررة بالكتابة خلال ثلاثة أشهر؟

1 تحديد المشكلة

لوحظ وجود كتابات ورسوم على الطاولات وجدران بعض الفصول، وظهر ذلك في صور الفصول المرفقة بملف التقويم، مما يؤثر على المظهر العام للمدرسة وعلى ملاحظة البيئة التعليمية في التقويم الخارجي، ويعكس ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الممتلكات العامة.

أدلة وجود المشكلة:

- صور الفصول الموثقة في ملف التقويم (آثار كتابة على الجدران).
- ملاحظات المعلمات أثناء الحصص والمناوبة.
- جولات ميدانية في الفصول (نموذج 3).
- آراء الطلبة (نموذج 2).

2 جمع البيانات وتحليلها

بيانات كمية	بيانات نوعية
• عدد الطاولات المتضررة في كل فصل ونسبتها. • عدد الجدران أو المساحات المتضررة. • أكثر الفصول والأماكن تضرراً.	• أسباب الكتابة من وجهة نظر الطلبة. • آراء المعلمات والإدارة. • أوقات حدوث الكتابة (الحصص، الانتظار، الفسحة).

الأداة	تُطبَّق على	التوقيت	المسؤولة
نموذج 1: حصر الطاولات والجدران المتضررة	جميع الفصول	الأسبوع الأول (قياس قبلي) ثم شهرياً	منسقة الأمن والسلامة صالحة السهيمي
نموذج 2: استبانة الطلبة	طلبة الصفوف من الرابع إلى السادس	الأسبوع الأول ونهاية البحث	الموجهة الطلابية هند العتيبي
نموذج 3: بطاقة الجولة الميدانية	الفصول والممرات	أسبوعياً	وكيلة المدرسة ثريا القثامي
نموذج 4: مقابلة المعلمات	معلمات الفصول	الأسبوع الثاني	رئيسة الفريق ثريا القثامي
التوثيق بالصور	عينة ثابتة من الطاولات والجدران	قبل التنفيذ وبعده	رائدة النشاط عيشة الحارثي

3 تحديد أسباب المشكلة

أسباب متوقعة يُتحقق منها بعد تحليل الاستبانة والمقابلات، وتُرتَّب حسب نسبة تكرارها.

م	السبب المتوقع	مصدر التحقق	نسبة التكرار بعد التحليل
1	قلة الوعي بأهمية المحافظة على ممتلكات المدرسة	استبانة الطلبة	تُحسب بعد الاستبانة والمقابلات (16/5/1448هـ)
2	غياب البدائل الإيجابية للتعبير عن الذات	استبانة الطلبة ومقابلة المعلمات	تُحسب بعد الاستبانة والمقابلات (16/5/1448هـ)
3	أوقات فراغ داخل الفصل بلا متابعة (حصص الانتظار وتأخر المعلمة)	الجولات والمقابلات	تُحسب بعد الاستبانة والمقابلات (16/5/1448هـ)
4	ضعف تطبيق قواعد السلوك والمواظبة الخاصة بالممتلكات	سجل المخالفات والمقابلات	تُحسب بعد الاستبانة والمقابلات (16/5/1448هـ)
5	تأثير الأقران وتقليد الكتابات الموجودة	استبانة الطلبة	تُحسب بعد الاستبانة والمقابلات (16/5/1448هـ)
6	قلة الأنشطة التي تعزز الانتماء والمسؤولية	مقابلة المعلمات	تُحسب بعد الاستبانة والمقابلات (16/5/1448هـ)

4 خطة العمل

م	الإجراء	يعالج السبب	المسؤولة	التوقيت	الشاهد
1	برنامج توعوي: إذاعة صباحية، ولقاء صفي عن المحافظة على الممتلكات العامة	1	الموجهة الطلابية هند العتيبي	جمادى الأولى	تقرير وصور
2	أنشطة بديلة للتعبير: لوحة «جدار الإبداع» في كل ممر، وركن رسم في الفصل	2	رائدة النشاط عيشة الحارثي	جمادى الأولى – شعبان	صور اللوحات وأعمال الطلبة
3	تنظيم حصص الانتظار بأنشطة محددة ومتابعة الفصول في أوقات الفراغ	3	وكيلة المدرسة ثريا القثامي	مستمر	جدول الانتظار
4	تفعيل قواعد السلوك الخاصة بالممتلكات، وتعهد الطلبة، وإشعار أولياء الأمور	4	الموجهة الطلابية هند العتيبي	جمادى الأولى	التعهدات والإشعارات
5	مبادرة «فصلي مسؤوليتي»: تنظيف الطاولات بمشاركة الطلبة، وسفيرة نظافة لكل فصل	5 و6	رائدة النشاط عيشة الحارثي ومعلمات الفصول	جمادى الآخرة	تقرير المبادرة وصور قبل وبعد
6	مسابقة «الفصل المثالي» شهرياً وحوافز للفصول الملتزمة	6	لجنة التميز برئاسة مديرة المدرسة	شهرياً	نتائج المسابقة والتكريم
7	رفع ما يحتاج صيانة أو دهان للجهة المختصة بعد التنظيف	—	منسقة الأمن والسلامة صالحة السهيمي	جمادى الآخرة	رقم البلاغ

5 تنفيذ الخطة (الجدول الزمني)

الإجراء	جمادى الأولى	جمادى الآخرة	رجب	شعبان
القياس القبلي وجمع البيانات	●			
البرنامج التوعوي وتفعيل القواعد والتعهدات	●			
جدار الإبداع والأنشطة البديلة	●	●	●	●
مبادرة «فصلي مسؤوليتي» وسفيرات النظافة		●	●	
مسابقة الفصل المثالي		●	●	●
القياس الشهري والتقرير النهائي		●	●	●

6 متابعة التنفيذ وجمع البيانات

تُعبَّأ من نموذج 1 بعد كل حصر، وتُحسب نسبة التحسن = (العدد قبل التنفيذ – العدد الحالي) ÷ العدد قبل التنفيذ × 100.

الفترة	التاريخ	عدد الطاولات المتضررة	عدد الجدران / المساحات المتضررة	نسبة التحسن	ملاحظات
قبل التنفيذ	الأربعاء 10/5/1448هـ	يُرصد في الحصر القبلي	يُرصد في الحصر القبلي	—	
بعد شهر	الأربعاء 8/6/1448هـ	يُرصد في موعده	يُرصد في موعده	تُحسب تلقائياً	
بعد شهرين	الأربعاء 7/7/1448هـ	يُرصد في موعده	يُرصد في موعده	تُحسب تلقائياً	
بعد ثلاثة أشهر	الأربعاء 5/8/1448هـ	يُرصد في موعده	يُرصد في موعده	تُحسب تلقائياً	

7 تحليل النتائج والتقويم

مؤشر النجاح	المستهدف	النتيجة الفعلية	تحقق؟
انخفاض عدد الطاولات المتضررة	50% بعد شهرين، و80% بعد ثلاثة أشهر	تُقاس في 5/8/1448هـ	
عدم ظهور كتابات جديدة على الجدران	صفر حالات جديدة في الجولات	تُقاس في 5/8/1448هـ	
تحسن اتجاه الطلبة نحو المحافظة على الممتلكات (الاستبانة البعدية)	90% فأعلى	تُقاس في الاستبانة البعدية	
مشاركة الفصول في مبادرة «فصلي مسؤوليتي»	جميع الفصول	تُقاس في 5/8/1448هـ	

أدوات التقويم: المقارنة القبلية والبعدية، ملاحظات المعلمات، آراء الطلبة، التوثيق بالصور.

نقاط القوة

تُكتب بعد الحصر النهائي (5/8/1448هـ)

جوانب تحتاج إلى تحسين

تُكتب بعد الحصر النهائي (5/8/1448هـ)

8 التوثيق والاستدامة

- إعداد تقرير نهائي بالنتائج والصور، ورفعه في ملف التقويم تحت المؤشرات المرتبطة.
- عرض النتائج على المنسوبات في اجتماع، وعلى أولياء الأمور برسالة مختصرة.
- تضمين الإجراءات الناجحة في الخطة التشغيلية للعام القادم وخطة التحسين (المؤشر 4-1-1-3).
- استمرار جولة شهرية بنموذج 1 بعد انتهاء البحث.

الموجهة الطلابية	رائدة النشاط	رئيسة فريق البحث	منسقة الأمن والسلامة	مديرة المدرسة
هند العتيبي	عيشة الحارثي	ثرياء القثامي	صالحة السهيمي	ناديه عوض الصخيري

التطبيق المبسّط للبحث الإجرائي

أدوات تنفيذ وقياس أسبوعية تحوّل خطة البحث إلى ممارسة يومية موثقة، وتُعين الفريق على اتخاذ قرار مبني على البيانات لكل فصل.

1 خطة التنفيذ للأسابيع الستة الأولى

خطة مكتوبة بمواعيد هجرية فعلية من بداية البحث، قابلة للتعديل وفق الإجازات وجدول المدرسة. يُوثَّق التنفيذ الفعلي في سجل التطبيق بعد حدوثه.

الأسبوع	الفترة 1448هـ	الهدف	الإجراء	الشاهد المتوقع
1	7/5 – 11/5	تحديد حجم المشكلة	الحصر القبلي لجميع الفصول (الأربعاء 10/5) وتصوير العينة الثابتة، وتطبيق استبانة الطلبة القبلية.	نموذج 1 معبأ، صور قبلية، استبانات
2	14/5 – 18/5	فهم الأسباب	مقابلات المعلمات الست (14 إلى 16/5)، وتحليل الاستبانة وترتيب الأسباب حسب نسبة تكرارها.	نموذج 4 موقّع، جدول الأسباب مرتباً
3	21/5 – 25/5	التوعية وتفعيل القواعد	إذاعة صباحية ولقاء صفي قصير في كل فصل، وتوقيع تعهد الطلبة، وإشعار أولياء الأمور.	تقرير الإذاعة، التعهدات، الإشعارات
4	28/5 – 2/6	البدائل الإيجابية	تدشين «جدار الإبداع» في الممرات وركن الرسم في الفصول، وتنظيم أنشطة حصص الانتظار.	صور الجدار وأعمال الطلبة، جدول الانتظار
5	5/6 – 9/6	المسؤولية المشتركة	مبادرة «فصلي مسؤوليتي» وتعيين سفيرة نظافة لكل فصل، والحصر الشهري الأول (الأربعاء 8/6).	صور قبل وبعد، نموذج 1 الشهري
6	12/6 – 16/6	القياس والقرار	مقارنة نتائج الحصر القبلي بالشهري لكل فصل، وتأمل الفريق، واتخاذ قرار لكل فصل، وتعديل الخطة للشهرين القادمين.	جدول المقارنة، محضر الفريق، الخطة المعدلة

مسؤولة التنفيذ: رئيسة فريق البحث ثريا القثامي. المساندة: الموجهة الطلابية تراجع الأدوات، ورائدة النشاط توثّق بالصور، ومنسقة الأمن والسلامة تنفّذ الحصر.

2 طريقة الجلسة الصفية القصيرة (15 دقيقة)

الوقت	ما تفعله المعلمة والطالبات
3 دقائق	تعرض المعلمة صورة طاولة نظيفة وأخرى متضررة، وتسأل: أيهما تحبين أن تجلسي عليها؟
9 دقائق	نشاط قصير: تتفق الطالبات على قاعدة للفصل وتكتبها كل مجموعة على بطاقة تُعلّق في ركن الفصل، وتُكلَّف سفيرة النظافة.
3 دقائق	تغذية راجعة: تذكر كل طالبة شيئاً واحداً ستفعله للمحافظة على طاولتها، وتُشكر المجموعات الملتزمة.

3 سجل التطبيق والتغذية الراجعة

يُكتب التنفيذ الفعلي بعد حدوثه؛ والإجراء المقترح يساعد الفريق على بدء كل مرحلة.

المرحلة	الإجراء المقترح	التاريخ الفعلي	ما حدث والتعديل التالي
1	الحصر القبلي وتصوير العينة الثابتة.		
2	تطبيق الاستبانة القبلية وتحليلها.		
3	مقابلات المعلمات وترتيب الأسباب.		
4	الإذاعة والجلسة الصفية القصيرة في كل فصل.		
5	توقيع التعهدات وإشعار أولياء الأمور.		
6	تدشين جدار الإبداع وركن الرسم.		
7	مبادرة «فصلي مسؤوليتي» وتعيين السفيرات.		
8	الحصر الشهري الأول ومراجعة النتائج قبل القرار.		

تغذية راجعة مرتبطة بالفصول

الفصل	ما نجح فيه	خطوته التالية	موعد المراجعة

صياغة مقترحة للتوثيق: «نُظّفت طاولات الفصل بمشاركة الطالبات، وعُلّقت قاعدة الفصل. في الجولة القادمة نتحقق من عدم ظهور كتابات جديدة على الطاولات الأمامية».

تأمل فريق البحث بعد كل حصر

ما الذي نجح هذا الأسبوع؟ .....

ما الذي لم ينجح ولماذا؟ .....

ما الذي سنعدّله في الأسبوع القادم؟ .....

4 مقارنة النتائج واتخاذ القرار لكل فصل

تُعبّأ بعد كل حصر شهري من نموذج 1. نسبة التحسن للفصل = (القبلي − البعدي) ÷ القبلي × 100.

م	الفصل	الطاولات المتضررة قبل	بعد	الفرق	نسبة التحسن	القرار
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

نسبة تحسن الفصل	القرار
نسبة التحسن 80% فأكثر	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
من 50% إلى أقل من 80%	متابعة دورية واستمرار الخطة
أقل من 50%	متابعة مكثفة: جلسة صفية إضافية وتواصل مع أولياء الأمور

5 مثال محسوب لقراءة النتائج

بيانات افتراضية لتوضيح طريقة المقارنة والحساب واتخاذ القرار، وليست نتائج المدرسة.

الفصل الافتراضي	قبل	بعد شهر	الفرق	نسبة التحسن	القرار
فصل أ	10	2	8	80%	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
فصل ب	8	1	7	88%	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
فصل ج	12	4	8	67%	متابعة دورية واستمرار الخطة
فصل د	6	0	6	100%	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
فصل هـ	9	2	7	78%	متابعة دورية واستمرار الخطة
فصل و	7	1	6	86%	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
فصل ز	11	5	6	55%	متابعة دورية واستمرار الخطة
فصل ح	5	1	4	80%	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
فصل ط	8	2	6	75%	متابعة دورية واستمرار الخطة
فصل ي	10	3	7	70%	متابعة دورية واستمرار الخطة
فصل ك	6	1	5	83%	إغلاق الفصل مع متابعة شهرية
فصل ل	8	2	6	75%	متابعة دورية واستمرار الخطة

النتيجة	الحساب في المثال
المقارنة	12 فصلاً لها حصر قبلي وبعدي؛ لا يوجد استبعاد.
مجموع الطاولات المتضررة قبل التنفيذ	100 طاولة؛ بمتوسط 8.33 طاولة للفصل.
مجموع الطاولات المتضررة بعد شهر	24 طاولة؛ بمتوسط 2.00 طاولة للفصل.
نسبة التحسن العامة	(100 − 24) ÷ 100 × 100 = 76.0%؛ المستهدف 50% بعد شهرين: متحقق مبكراً.
الفصول التي بلغت 80%	6 من 12 فصلاً، أي 50%؛ المستهدف جميع الفصول بعد ثلاثة أشهر: لم يتحقق بعد.

القراءة: تحقق مستهدف الشهرين مبكراً على مستوى المدرسة، لكن نصف الفصول فقط بلغ 80%؛ فتُوجَّه الجهود في الشهرين القادمين إلى الفصول ذات المتابعة الدورية والمكثفة.

نماذج البحث الإجرائي

1 نموذج 1: حصر الطاولات والجدران المتضررة

تاريخ الحصر: ..... الفترة: ☐ قبل التنفيذ ☐ بعد شهر ☐ بعد شهرين ☐ بعد ثلاثة أشهر القائمة بالحصر: .....

م	الفصل	عدد الطاولات	الطاولات المتضررة	النسبة	الجدران المتضررة (نعم / لا والمكان)	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
المجموع						

الطاولة المتضررة: عليها كتابة أو رسم ظاهر لم يُزل. تُصوَّر عينة ثابتة من الطاولات في كل حصر.

2 نموذج 2: استبانة الطلبة (من الرابع إلى السادس)

الصف: ..... التطبيق: ☐ قبلي ☐ بعدي لا يُكتب الاسم.

م	العبارة	نعم	أحياناً	لا
1	أحب فصلي عندما يكون نظيفاً ومرتباً.	☐	☐	☐
2	الكتابة على الطاولة تضايقني.	☐	☐	☐
3	أعرف أن طاولات المدرسة ملك للجميع ويجب المحافظة عليها.	☐	☐	☐
4	أكتب أو أرسم على الطاولة أحياناً.	☐	☐	☐
5	أكتب على الطاولة عندما لا يكون عندي عمل في الحصة.	☐	☐	☐
6	أكتب على الطاولة لأن زميلاتي يكتبن عليها.	☐	☐	☐
7	لو وُجد مكان مخصص للرسم والكتابة سأستخدمه بدل الطاولة.	☐	☐	☐
8	أرغب أن أكون سفيرة نظافة لفصلي.	☐	☐	☐

برأيك، لماذا يكتب بعض الطلبة على الطاولات؟

_____

_____

ما اقتراحك لحل المشكلة؟

_____

_____

3 نموذج 3: بطاقة الجولة الميدانية الأسبوعية

التاريخ	الفصول أو الأماكن	كتابات جديدة؟	الإجراء المتخذ	القائمة بالجولة

4 نموذج 4: مقابلة المعلمات

عدد المعلمات اللاتي تمت مقابلتهن: .....

التاريخ: .....

م	السؤال	ملخص الإجابات
1	متى تلاحظين الكتابة على الطاولات غالباً؟	
2	ما الأسباب من وجهة نظرك؟	
3	ما الإجراءات التي تتخذينها حالياً؟	
4	ما الذي تقترحينه لعلاج المشكلة؟	
5	هل تلاحظين فرقاً بين الصفوف الأولية والعليا؟	

عينة المقابلات وجدولها

عينة مختارة من 6 معلمات (3 للصفوف الأولية و3 للعليا) بتنوع التخصصات. تُجرى المقابلة في حصة فراغ المعلمة، وتوقّع المعلمة بعد إجرائها.

م	المعلمة	التخصص	الصفوف	موعد المقابلة	توقيع المعلمة بعد المقابلة
1	أبرار موسى الطلحي	لغتي	الأولية	الأحد 14/5/1448هـ	
2	بدرية محيل العتيبي	دراسات إسلامية	الأولية	الأحد 14/5/1448هـ	
3	عزة عبدالرحمن الزهراني	رياضيات	الأولية	الاثنين 15/5/1448هـ	
4	نوف محمد البيالي	لغتي	العليا	الاثنين 15/5/1448هـ	
5	هلا سفر العتيبي	علوم	العليا	الثلاثاء 16/5/1448هـ	
6	نجلاء عواض الصخيري	دراسات اجتماعية	العليا	الثلاثاء 16/5/1448هـ	

جدول الزيارات الميدانية الأسبوعية — كل أربعاء (نموذج 3)

م	الموعد	المهمة	النطاق	المسؤولة	كتابات جديدة؟	التوقيع
1	الأربعاء 10/5/1448هـ	الحصر القبلي (نموذج 1) + جولة	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
2	الأربعاء 17/5/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
3	الأربعاء 24/5/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
4	الأربعاء 1/6/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
5	الأربعاء 8/6/1448هـ	جولة + الحصر الشهري (نموذج 1)	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
6	الأربعاء 15/6/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
7	الأربعاء 22/6/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
8	الأربعاء 29/6/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
9	الأربعاء 7/7/1448هـ	جولة + الحصر الشهري (نموذج 1)	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
10	الأربعاء 14/7/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
11	الأربعاء 21/7/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
12	الأربعاء 28/7/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
13	الأربعاء 5/8/1448هـ	جولة + الحصر الشهري (نموذج 1)	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
14	الأربعاء 12/8/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
15	الأربعاء 19/8/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		
16	الأربعاء 26/8/1448هـ	جولة أسبوعية	الفصول والممرات	ثريا القثامي / صالحة السهيمي		

بحوث موثّقة من العام الدراسي 1447هـ

بحوث نفّذتها المدرسة في العام الماضي، منقولة من ملفاتها الأصلية في درايف المدرسة مع تواقيع المنفذات.

1

دراسة حالة وخطة علاجية · الفصل الدراسي الأول 1447هـ

غياب أحد الوالدين وأثره على الطالب

المصدر: **ملف المدرسة في درايف** | العام: **الفصل الدراسي الأول 1447هـ** | مستوى السرية: **سري**

الحالة	الصف	الوضع الأسري
الطالب (ع)	**الأول الابتدائي**	**فاقد لوالدته، يعيش مع والده وتتولى جدته رعايته**
الملاحظات الأولية	المميزات الإيجابية	مدة الخطة
سلوك عدواني وعناد، مع قلة في الاهتمام المنزلي	**ذكاء واضح وفطنة عالية**	**أربعة أسابيع**

1 المقدمة

تُعد الأسرة الركيزة الأساسية في تنشئة الطالب وبناء شخصيته النفسية والاجتماعية والتعليمية، ويسهم وجود الوالدين معاً في توفير الاستقرار العاطفي اللازم لنمو سليم. ويُعد غياب أحد الوالدين من المشكلات المؤثرة بشكل مباشر على الطالب سلوكياً وتعليمياً، مما يستدعي تدخلاً تشخيصياً وعلاجياً متخصصاً.

2 مشكلة البحث ووصف الحالة

تتمثل مشكلة البحث في الآثار النفسية والسلوكية المترتبة على غياب أحد الوالدين عن حياة الطالب، وكيفية التعامل مع هذه الآثار لضمان استمرار العملية التعليمية والتربوية بشكل فعّال.

3 الأدوار المساندة

دور المعلمة

- احتواء الطالب داخل الفصل
- توفير بيئة آمنة وداعمة
- تعزيز السلوك الإيجابي
- المتابعة المستمرة

دور الموجهة الطلابية

- دراسة متعمقة للحالة
- التواصل مع ولي الأمر
- إعداد خطة إرشادية
- المتابعة المنتظمة

4 الخطة العلاجية الأسبوعية

الأسبوع	الإجراء العلاجي	الجهة المنفذة	مؤشر النجاح
الأول	جلسة إرشاد فردي	الموجهة الطلابية	هدوء ملحوظ في السلوك
الثاني	تعزيز إيجابي داخل الفصل	المعلمة	انخفاض السلوك العدواني
الثالث	إشراك في نشاط جماعي	المعلمة	تحسن التفاعل الاجتماعي
الرابع	متابعة مع ولي الأمر	الموجهة الطلابية	استقرار سلوكي عام

5 مؤشرات التحسن والنتائج

- انخفاض السلوك العدواني بشكل كبير.
- تحسن ملحوظ في التحصيل الأكاديمي.
- زيادة التفاعل الاجتماعي مع الأقران.
- تحسن التركيز والانتباه في الفصل.

النتيجة النهائية

تحسّن سلوك الطالب بشكل ملحوظ بعد جهود الاحتواء، وازداد تفاعله وتركيزه، وأصبح من الطلاب المنتبهين والفاعلين في التواصل المدرسي ومع ولي الأمر.

6 التوصيات

- الاستمرار في الدعم النفسي والتربوي المقدم للطالب بشكل منتظم.
- المتابعة الدورية للحالة وتقييم التقدم المحرز بشكل منتظم.
- تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة لضمان بيئة داعمة متكاملة.
- توفير برامج إثرائية تسهم في تطوير مهارات الطالب الأكاديمية والاجتماعية.

المعلمة	الموجهة الطلابية	مديرة المدرسة
أبرار الطلحي	أمل الهيفاني	ناديه عوض الصخيري

2

بحث تشخيصي صحي – تربوي · العام الدراسي 1447هـ

بحث تشخيصي تربوي وصحي: أثر تذبذب سكر الدم على التعلم

المصدر: **ملف المدرسة في درايف** | العام: **العام الدراسي 1447هـ** | مستوى السرية: **سري**

الحالة	الصف	الحالة الصحية
الطالبة (ت. م)	**الثاني الابتدائي**	**داء السكري مع تذبذب القراءات (ارتفاع/انخفاض) أثناء اليوم الدراسي**
المستوى التحصيلي	الأطراف ذات العلاقة	مدة الخطة
منخفض جداً وفق ملاحظات المعلمة ونتائج التقويم	**قائدة المدرسة – الموجهة الصحية – الموجهة الطلابية – معلمة لغتي**	**6 إلى 8 أسابيع**

1 المقدمة

حرصاً على مصلحة الطالبة الصحية والتعليمية، أُعد هذا البحث لتوثيق الحالة داخل المدرسة، وتحليل أثر تذبذب سكر الدم على التعلم والسلوك الصفي، وتوضيح الإجراءات التي قامت بها المدرسة، واقتراح خطة تدخل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

2 مشكلة البحث ووصف الحالة

صحياً: تذبذب القراءات يؤدي إلى ضعف التركيز وخمول أو توتر حسب الحالة. تربوياً: صعوبة في إنجاز المهام والحاجة لتجزئة الأنشطة وتكرار التوجيه. أسرياً: تعاون محدود؛ حضور ولي الأمر ليوم واحد ثم انقطاع، وضعف متابعة منزلية.

3 مصادر الاستدلال وأدوات التشخيص

- سجل الملاحظات الصفية اليومية (تركيز/تفاعل/إنجاز).
- نتائج التقويمات والاختبارات القصيرة.
- سجل متابعة الموجهة الصحية (قراءات/أعراض/إجراءات).
- سجل التواصل مع ولي الأمر (اتصال/رسالة/زيارة/محاضر).
- استبيانات تشخيصية مختصرة: المعلمة – ولي الأمر – الموجهة الصحية.

4 التحليل والتشخيص (غير طبي)

العبارة التشخيصية

عامل صحي مؤثر: تذبذب السكر ينعكس على الانتباه والمزاج والقدرة على الإنجاز. عامل أسري: ضعف المتابعة يقلل فرص التحسن والاستقرار. عامل تعليمي: فجوات مبكرة في مهارات القراءة والكتابة تحتاج تدخلاً علاجياً. (تشخيص تربوي/مدرسي لا يُغني عن الخطة الطبية المكتوبة من الجهة الصحية.)

5 أهداف الخطة

- تحسين القراءة: إتقان 10 إلى 15 كلمة عالية التكرار بنسبة 80%.
- تحسين الكتابة: كتابة جمل قصيرة (3 إلى 5 كلمات) بخط واضح مع تقليل الأخطاء.
- رفع المشاركة الصفية عبر التعزيز الإيجابي.
- تنظيم المتابعة الصحية: توثيق يومي للقراءات والأعراض وفق نموذج ثابت.

خطة الرعاية الصحية المدرسية

- طلب خطة طبية مكتوبة ومحدثة من الجهة الصحية: مؤشرات الخطر، الإجراءات، أرقام التواصل.
- تفعيل نموذج متابعة يومي (قراءة – أعراض – إجراء – تواصل).
- تحديد مكان آمن وهادئ للطالبة عند انخفاض أو ارتفاع القراءات حسب الخطة الطبية.
- التأكيد على توفير المستلزمات من ولي الأمر (قياس/وجبات/علاج إسعافي إن لزم).

الخطة العلاجية التعليمية (لغتي)

- جلسات علاجية قصيرة 2 إلى 3 مرات أسبوعياً (15 إلى 20 دقيقة) – معلمة لغتي.
- استراتيجيات: قراءة موجهة – بطاقات كلمات – تكرار منظم – تعليم متعدد الحواس.
- تيسيرات صفية: تجزئة المهام، وقت إضافي، جلوس قريب من المعلمة، بدائل تقييم عند تأثر الحالة الصحية.
- قياس أسبوعي (قائمة كلمات/إملاء قصير) وتسجيل مستوى التحسن.

6 التواصل والتعاون الأسري

- قناة تواصل رسمية واحدة وتوثيق جميع الاتصالات في سجل.
- اجتماع رسمي موثق بمحضر لشرح الالتزامات والمخاطر.
- توقيع ولي الأمر على الاطلاع على الخطة الصحية والتربوية.
- عند استمرار عدم التعاون: رفع إفادات دورية لإدارة التعليم وفق القنوات الرسمية.

7 الجدول الزمني والتوصيات

الفترة	الإجراء
الأسبوع 1 إلى 2	تشخيص دقيق + بدء الجلسات العلاجية

الفترة	الإجراء
الأسبوع 3 إلى 4	متابعة التقدم + تعديل الخطة عند الحاجة
الأسبوع 5 إلى 6	قياس الأثر + إعداد تقرير متابعة

- اعتماد الخطة الصحية والتربوية المقترحة.
- دعم المدرسة بخطاب إرشادي يوضح آلية إلزام ولي الأمر بالتعاون وفق الأنظمة.
- اعتماد متابعة زمنية (4 إلى 6 أسابيع) مع تقارير دورية وفق المتبع في إدارة التعليم.

الموجهة الصحية	الموجهة الطلابية	معلمة لغتي	مديرة المدرسة
سارة العصيمي	أمل الهيفاني	عيشة الحارثي	ناديه عوض الصخيبري

البرامج الوقائية المساندة 1448هـ

نفّذت المدرسة في الفصل الدراسي الأول من العام 1448هـ برامج وقائية ترتبط مباشرة بالحالات المدروسة في هذا الملف، وتُعد شواهد على تفعيل التوصيات على مستوى المدرسة كاملة لا على مستوى الحالة الفردية فقط.

1 ورشة عمل «لا للتنمر»

المنفذة: **هند العتيبي** | التاريخ: **الفصل الأول 1448هـ** | المجال: **التوجيه الطلابي** | الفئة: **الطالبات والمعلمات**

يرتبط بـ	الحالة الثالثة: السلوك العدواني والتنمر
الأهداف	تعريف الطالبات بمفهوم التنمر وأشكاله وآثاره، والتمييز بين المزاح المقبول والتنمر، وتعزيز الاحترام والتسامح، وتشجيع طلب المساعدة عند التعرض للتنمر أو مشاهدته.
آلية التنفيذ	حوار حول مفهوم التنمر، ومناقشة مواقف مدرسية (السخرية، الإقصاء، الاعتداء اللفظي والجسدي)، وتوضيح التصرف الصحيح وإبلاغ شخص بالغ موثوق، ورسومات توعوية للتلوين.
التوصيات	الاستمرار في التوعية ضد التنمر، ومتابعة الحالات السلوكية، وتشجيع الإبلاغ، وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة.

التقرير والشواهد محفوظة في مجلد التوجيه الطلابي · المنفذة: هند العتيبي

2 برنامج «الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية»

المنفذة: **فاطمه الحارثي** | التاريخ: **الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1448هـ (22 سبتمبر 2026م)** | المجال: **وقائي** | الفئة: **الطلبة وأولياء الأمور**

يرتبط بـ	الحالة السابعة: الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية
الأهداف	تطبيق قواعد الخصوصية الرقمية، ومعرفة التصرف عند الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عبر (كلنا أمن) أو 1909، والالتزام بآداب السلوك الرقمي، وتنظيم وقت الألعاب بما لا يطغى على النوم والدراسة.
آلية التنفيذ	حصص توجيه جمعي، وجلسة عن الابتزاز الإلكتروني وقاعدة «لا تدفع، لا تحذف، بلّغ»، وورشة إدارة وقت الشاشة والتصنيفات العمرية، وركن اليوم العالمي للإنترنت الآمن، ونشرة لأولياء الأمور.
التوصيات	مساندة الأهل في تقليل الوقت الذي يقضيه الأبناء في الألعاب الإلكترونية والإنترنت.

التقرير والشواهد محفوظة في مجلد التوجيه الطلابي · المنفذة: فاطمه الحارثي

3 برنامج «حماية الطفل من الإيذاء»

المنفذة: **فاطمه الحارثي** | التاريخ: **الخميس 28 ربيع الأول 1448هـ (10 سبتمبر 2026م)** | المجال: **وقائي – وزاري**

الفئة: **جميع الطلبة ومنسوبات المدرسة**

يرتبط بـ	الحالات: غياب أحد الوالدين، الانطواء، العدوان
الأهداف	تمييز أنواع الإيذاء، ومعرفة قنوات الإفصاح الآمن وخط مساندة الطفل 116111، وإتقان المنسوبات رصد المؤشرات والتصرف النظامي، والإبلاغ الإلزامي عن أي اشتباه في 100% من الحالات.
آلية التنفيذ	جلسات توجيه جمعي بعمر كل مرحلة (قاعدة «جسدي ملكي»)، ولقاء تدريبي للمنسوبات عن مؤشرات الإيذاء والإحالة السرية، وبروتوكول داخلي مكتوب، ونشرة للتربية الإيجابية لأولياء الأمور.
التوصيات	استمرار تزويد الطلاب والطالبات برقم مساندة الطفل وتوضيح فائدته.

التقرير والشواهد محفوظة في مجلد التوجيه الطلابي · المنفذة: فاطمه الحارثي

الخاتمة والتوصيات العامة

كشفت البحوث التشخيصية والإجرائية والصحية الواردة في هذا الملف أن مشكلات المتعلمين في المرحلة الابتدائية نادراً ما تنشأ عن سبب واحد، بل تتشابك فيها العوامل الذاتية والأسرية والمدرسية، وأن المعالجة الفاعلة تبدأ بالفهم العميق قبل التدخل، وتقوم على الشراكة الحقيقية بين المدرسة والأسرة، وتعتمد على أهداف قابلة للقياس ومتابعة منتظمة.

كما أكدت النتائج أن الاكتشاف المبكر والتواصل السريع مع ولي الأمر يختصران كثيراً من الجهد والوقت، وأن البيئة الصفية الآمنة والمتفهمة عامل مشترك في نجاح جميع الخطط العلاجية.

التوصيات العامة على مستوى المدرسة

المحور	التوصية
الشراكة مع ولي الأمر	اعتماد التواصل مع ولي الأمر جزءاً من العلاج في كل حالة: لقاء أول برئاسة مديرة المدرسة، ومتابعة أسبوعية، ولقاء منتصف الخطة، ولقاء ختامي، مع توثيق ذلك في سجل التواصل ومحضر اللقاء.
الاكتشاف المبكر	تطبيق الاختبارات التشخيصية واستمارات الرصد في الأسابيع الأولى من كل فصل دراسي.
الشراكة الأسرية	تفعيل قنوات تواصل منتظمة مع الأسر وإلزامية الإبلاغ عن الظروف الطارئة بسرية.
التنمية المهنية	تدريب المعلمات على مهارات اكتشاف الحالات والتعامل التربوي معها.
البرامج الوقائية	تنفيذ برامج جماعية سنوية: مكافحة التنمر، المواطنة الرقمية، الانضباط، الدعم النفسي.
التوثيق والسرية	توحيد نماذج دراسة الحالة وحفظها في ملف سري لدى الموجهة الطلابية.
التكامل مع الجهات المساندة	الإحالة المنظمة للجهات الصحية والنفسية والتربية الخاصة عند الحاجة.

المرجعية واعتماد الملف

المرجعية

- قواعد تنظيم السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام – وزارة التعليم.
- الأدلة الإجرائية للتوجيه والإرشاد الطلابي في مدارس التعليم العام – وزارة التعليم.
- أدلة الصحة المدرسية والبرامج الوقائية – وزارة التعليم.
- مراجع علم النفس التربوي ومنهجية دراسة الحالة في الإرشاد المدرسي.

اعتماد الملف

اطّلعت لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة على البحوث التشخيصية الواردة في هذا الملف، وأقرّت منهجيتها وخططها العلاجية، وأوصت بتعميم ما ورد فيها من إجراءات وقائية على منسوبات المدرسة، مع الالتزام التام بسرية معلومات الحالات.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ناديه عوض الصخيري	مديرة المدرسة – رئيسة اللجنة	
2	ثرياء القثامي	وكيلة المدرسة	
3	هند العتيبي	الموجهة الطلابية – مقررة اللجنة	
4	فاطمه الحارثي	الموجهة الصحية	
5	عيشة الحارثي	رائدة النشاط	

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

الختم الرسمي

المملكة العربية السعودية – وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

للتواصل: 0559752844 · 30800@taifdue.gov.sa · تاريخ الاعتماد: 18/5/1448هـ